EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93626
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 27-09-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MANUEL ROBUSTIANO PEREZ SALAZAR			RUN	: 11.111.831-0
F.Nac	: 07-11-1967	Edad	: 56 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: Trilico Camino A Torrecillas			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 975313412		
Fecha Ingreso	: 2024-09-11	Fecha Egreso	: 27-09-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I26.0-EMBOLIA PUMONAR CON MENCIÓN DE CORAZÓN PULMONAR AGUDO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

TEP multisegmentario riesgo intermedio alto- PESI 136 - Insuficiencia respiratoria aguda, resuelta
ITU por Pseudomonas aeruginosa tratada
Politraumatismo reciente: Fx pelvis + Fx fémur derecho + Fx clavícula + Fx de base de cráneo con Hematoma subdural
Sd. Down
Crisis dialéptica en estudio y tratamiento

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. Q90.X-SINDROME DE DOWN. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I62.9-HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMATICA), NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. S02.1-FRACTURA DE LA BASE DEL CRANEO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. T91.2-SECUELAS DE OTRA FRACTURA DEL TORAX Y DE LA PELVIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con Sd de Down, con antecedente de politraumatismo reciente en agosto/2024, con fractura de pelvis, fractura de femur derecho, fractura de clavícula, fractura de base de cráneo con hematoma subdural, hospitalizado en HODOM desde el 02.09.24 para rehabilitación, el 10/09/24 a las 16 hrs aprox presenta cuadro de compromiso súbito de conciencia, asociado a desviación de la mirada y rigidez generalizada de aprox 2 minutos de duración. Posterior al episodio se mantuvo somnoliento por aprox 30 min. Se llama a SAMU en donde se constata desaturación, siendo apoyado con O2 por MMV. En urgencias se solicitan exámenes dentro de los que destaca lactato 3.0, dimero D 9191 y Troponina 620 la cual sube 1640 al control. Se realiza TAC de cerebro (lesiones microangiopaticas en sustancia blanca) y AngioTC de torax el cual informa TEP de ramas principales de arteria pulmonar y ramas segmentarias y subsegmentarias, con signos de sobrecarga del VD.
En lo infeccioso, ITU - ASOC CATETER URINARIO, se rescata UC (+) Pseudomonas aeruginosa MS, estuvo con meropenem y posteriormente completó 5 días con ceftazidima.
Favorable evolucion general, orinando espontaneo
25.9.24 CREA 0.6, K 4.1

PLAN DE MANEJO:

CONTROL 2 SEMANAS POLI TACO
CONTROL EN POLICLINICO DE TRAUMATOLOGIA HSC CON DR GUSTAVO MUÑOZ EN 15 DIAS
CONTROL 3 SEMANAS POLI NEUROLOGIA
CONTROL 30 DIAS POLI MED INT

***CONTROL EQUIPO DE CADERA TMT H CHILLAN (HORA PENDIENTE)

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo en cama a tolerancia por Kine
2. regimen oral
3. DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
4. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL

OBSERVACIONES:

VALORACION POR TRAUMATOLOGIA :
NO AUTORIZO CARGA
SÍ PUEDE --> EJERCICIOS EN CAMA, SENTARSE BORDE DE CAMA, PASO A SILLA DE RUEDAS O A SILLÓN CUANDO YA ESTE EN DOMICILIO HABIENDO ENSEÑADO EL KINESIOLOGO PREVIAMENTE A CUIDADORES TECNICA DE TRANSFERENCIAS
HOSPIT DOMICILIARIA PRA FAVORECER KNT MOTOR

CALDERON SOLIS CRISTIAN JOSE
MEDICO TRATANTE
15161784-0

JEFE SERVICIO